

Síndrome premenstrual

1. Introducción y relevancia clínica

El **síndrome premenstrual (SPM)** se define como un **conjunto de síntomas físicos, emocionales y conductuales** que aparecen durante la **fase lútea del ciclo menstrual** (5–10 días previos a la menstruación) y **desaparecen con el inicio del sangrado**.

Afecta a cerca del **70–80% de las mujeres en edad fértil**, aunque en su forma **moderada a severa (Trastorno Disfórico Premenstrual, TDPM)** ocurre en aproximadamente **3–8%**.

Los síntomas interfieren con la **vida laboral, académica, sexual o social**, y su diagnóstico requiere **ciclicidad y resolución completa tras la menstruación**.

- En EUNACOM: preguntan con frecuencia “¿cuál es la base fisiopatológica del SPM?” (respuesta: sensibilidad anormal a las fluctuaciones hormonales, especialmente progesterona), y “¿qué tratamiento farmacológico se utiliza?” (ISRS en TDPM).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La etiología exacta del SPM no está completamente aclarada, pero se han identificado varios mecanismos interrelacionados:

a. Fluctuaciones hormonales

- Durante la **fase lútea** (postovulatoria), aumentan la **progesterona y el estradiol**.
- En mujeres susceptibles, estas variaciones hormonales generan una **respuesta neuroquímica anormal**, especialmente en neurotransmisores del sistema nervioso central.

b. Disregulación serotoninérgica

- La **serotonina (5-HT)** desempeña un papel clave en el estado de ánimo, sueño y apetito.
- Las variaciones cíclicas de estrógenos y progesterona afectan la síntesis, recaptura y metabolismo de serotonina.

- Esto explica la eficacia de los **ISRS** (fluoxetina, sertralina) en casos moderados a graves.

c. Otros mecanismos

- Aumento de **aldosterona y renina** → retención de sodio y agua → edema, distensión mamaria.
- Cambios en **betaendorfinas** → mayor sensibilidad al dolor.
- Alteraciones en **prostaglandinas y GABA**, que modulan el estado de ánimo y la tensión.

En resumen, el SPM no se debe a un exceso hormonal, sino a una **hipersensibilidad del sistema nervioso central** a las fluctuaciones cíclicas hormonales.

3. Clínica: manifestaciones y diagnóstico clínico

a. Síntomas frecuentes

Físicos:

- Mastalgia o tensión mamaria.
- Distensión abdominal.
- Cefalea.
- Edema o sensación de hinchazón.
- Aumento de peso transitorio.
- Fatiga, cambios en el apetito.

Emocionales y conductuales:

- Irritabilidad o labilidad emocional.
- Ansiedad o depresión leve.
- Dificultad para concentrarse.

- Alteraciones del sueño.
- Deseo de aislamiento.
- Llanto fácil.

Los síntomas aparecen **de forma cíclica**, entre 5 y 10 días antes de la menstruación, y **desaparecen completamente durante la menstruación o inmediatamente después**.

b. Trastorno disfórico premenstrual (TDPM)

Es la forma **severa** del SPM y está incluido en el **DSM-5** (manual psiquiátrico).

Criterios diagnósticos principales:

- ≥ 5 síntomas, incluyendo al menos uno afectivo, en la mayoría de los ciclos.
- Presencia en la **última semana de la fase lútea**, con remisión durante la menstruación.
- Interferencia significativa con el trabajo, escuela o relaciones.
- Confirmación prospectiva mediante **registro diario de síntomas** durante al menos dos ciclos.

☐ En EUNACOM, el TDPM es la forma incapacitante del SPM y se trata con ISRS, no con anticonceptivos como primera opción.

4. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Depresión mayor	Síntomas persistentes, no cíclicos.
Trastorno de ansiedad	Ansiedad crónica, sin relación con ciclo.

Hipotiroidismo	Fatiga persistente, aumento de peso, sin relación cíclica.
Endometriosis o adenomiosis	Dolor pélvico orgánico, no limitado a fase lútea.
Trastorno bipolar	Episodios prolongados de alteración del ánimo.

El diagnóstico del SPM es **clínico** y requiere descartar causas orgánicas o psiquiátricas.

5. Evaluación diagnóstica

No existen pruebas de laboratorio específicas.

Se basa en la **historia clínica detallada** y en la **relación temporal con el ciclo menstrual**.

a. Elementos claves del diagnóstico:

1. **Ciclicidad:** síntomas aparecen en fase lútea y remiten tras la menstruación.
2. **Duración:** al menos 2 ciclos consecutivos documentados.
3. **Grado de interferencia:** afectan funcionalidad diaria.
4. **Ausencia de enfermedad orgánica o psiquiátrica primaria.**

b. Herramientas útiles:

- Registro diario de síntomas (DRSP o calendario personal).
 - Escala de severidad premenstrual (PRISM o Moos Menstrual Distress Questionnaire).
-

6. Tratamiento

El manejo depende de la severidad y la repercusión funcional de los síntomas.

a.

Medidas generales (leve a moderado)

- Ejercicio físico regular.
 - Dieta equilibrada con reducción de sal, cafeína y alcohol.
 - Incrementar consumo de calcio y magnesio.
 - Sueño adecuado y manejo del estrés (yoga, meditación).
 - Apoyo psicoeducativo.
-

b.

Tratamiento farmacológico

Nivel	Fármaco	Mecanismo / beneficio	Observaciones
1. Primera línea (moderado–grave)	ISRS (fluoxetina 20 mg/día, sertralina 50 mg/día, paroxetina 20 mg/día)	Modulan serotonina → alivio de síntomas afectivos y físicos	Pueden usarse continuamente o solo en fase lútea
2. Segunda línea	ACO combinados con drospirenona/etinilestradiol (Yaz, Yasmin)	Suprimen ovulación y estabilizan fluctuaciones hormonales	Eficaces en casos con mastalgia o edema
3. Alternativas	Análogos de GnRH, danazol, acetato de medroxiprogesterona	Inhiben función ovárica	Reservado para casos refractarios

4.	Calcio (1.200 mg/día), vitamina B6, magnesio	Alivian síntomas leves	Evidencia variable
----	--	------------------------	--------------------

Suplementos

□ En Chile, el MINSAL recomienda iniciar con **medidas higiénico-dietéticas + ISRS o ACO combinados con drospirenona**, según predominio de síntomas.

C.

Tratamiento no farmacológico

- **Psicoterapia cognitivo-conductual (TCC):** útil para síntomas afectivos y de ansiedad.
- **Ejercicio físico:** mejora la oxigenación cerebral y la regulación hormonal.
- **Apoyo grupal y educación menstrual:** refuerzan la adherencia terapéutica.

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Manejo
Disfunción laboral y social	Absentismo, bajo rendimiento	Tratamiento con ISRS/ACO
Afectación de relaciones personales	Irritabilidad, ansiedad	Terapia individual o de pareja
Trastornos del ánimo persistentes	Riesgo de depresión	Seguimiento psicológico
Trastorno disfórico premenstrual	Forma incapacitante del SPM	ISRS como primera línea

El pronóstico es excelente con tratamiento adecuado y educación sobre el ciclo menstrual.

La mayoría de las pacientes responde favorablemente a los ISRS o anticonceptivos.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El **SPM** ocurre en la **fase lútea** y desaparece con la menstruación.
2. Se debe a una **respuesta anormal del SNC a las fluctuaciones hormonales**.
3. El **TDPM** es la forma severa, con síntomas incapacitantes.
4. **ISRS (fluoxetina, sertralina)** son el tratamiento de elección en formas moderadas o graves.
5. **ACO con drospirenona** son útiles cuando predomina retención o mastalgia.
6. El **diagnóstico es clínico**: síntomas cíclicos que desaparecen postmenstruación.
7. El **registro prospectivo de síntomas** es clave para confirmar el diagnóstico.



Errores comunes

- Diagnosticar SPM sin descartar trastornos psiquiátricos o tiroideos.
- Indicar benzodiacepinas (no están recomendadas).
- Usar ACO sin documentar relación con el ciclo.
- No explicar a la paciente la naturaleza cíclica y benigna del cuadro.
- Tratar solo con analgésicos sin abordar los síntomas emocionales.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **SPM** es un conjunto de síntomas físicos y emocionales que **aparecen en la fase lútea** y desaparecen con la menstruación.
2. Se debe a **hipersensibilidad cerebral a las fluctuaciones hormonales**, no a un exceso hormonal.
3. El diagnóstico es **clínico** y requiere **ciclicidad documentada**.
4. **ISRS (fluoxetina, sertralina)** son el tratamiento de primera línea en casos moderados a graves.
5. **ACO con drospirenona** son útiles si predomina la retención o mastalgia.
6. El **TDPM** es la forma severa e incapacitante del SPM (criterios DSM-5).
7. Educación, estilo de vida saludable y apoyo psicológico mejoran el pronóstico.